IPS GUAYACANES
NIT 900.000.333-3 · Código de habilitación 050010000333
Carrera 80 # 34-20, Medellín, Antioquia · Teléfono (604) 000 3333

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
Registro de atención n.º GY-2026-000941

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: Martha Lucía Restrepo Gil
Documento: Cédula de ciudadanía 43.578.211
Fecha de nacimiento: 22/06/1979
Edad: 46 años
Sexo: Femenino
Estado civil: Casada
Ocupación: Contadora pública
Dirección: Calle 33 # 76-15, barrio Laureles
Municipio de residencia: Medellín, Antioquia · Zona urbana
Teléfono: 300 615 2290
Aseguradora: EPS Antioquia Vital · Régimen contributivo, cotizante
Persona responsable: Carlos Mario Uribe Toro · Esposo · 304 118 5532

2. DATOS DE LA ATENCIÓN
Fecha y hora de inicio: 20/01/2026 10:00
Fecha y hora de fin: 20/01/2026 10:30
Modalidad: Presencial, en la sede
Servicio: Consulta externa de medicina general
Tipo de consulta: Control
Finalidad de la consulta: Tratamiento, seguimiento de enfermedad crónica
Causa que motiva la atención: Enfermedad general
Acompañante: Asiste sola

3. MOTIVO DE CONSULTA
"Vengo a control. Me dan muchos calores y no estoy durmiendo bien."

4. ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente con antecedente de cáncer de mama izquierda tratado en 2023, en hormonoterapia con tamoxifeno 20 mg al día desde noviembre de 2023, con adherencia completa. Desde hace 4 meses presenta bochornos (oleadas de calor en cara y pecho) unas 8 a 10 veces al día, con sudoración nocturna que la despierta 3 a 4 veces por noche. Refiere cansancio en el día y le cuesta concentrarse en el trabajo. Ánimo conservado, sin tristeza persistente ni pérdida del interés. Niega sangrado vaginal anormal, dolor en huesos, tos, pérdida de peso y masas en las mamas. Último control en oncología el 10/12/2025: sin evidencia de enfermedad. Mamografía bilateral de noviembre de 2025: BI-RADS 2.

5. ANTECEDENTES
Personales patológicos: Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, diagnosticado el 15/03/2023. Receptores de estrógeno 90 %, de progesterona 70 %, HER2 negativo, Ki-67 de 18 %. Estadio IIA (T2 N0 M0). Estudio genético BRCA1 y BRCA2 negativo (2023).
Tratamiento oncológico:
- Cuadrantectomía izquierda con ganglio centinela negativo, abril de 2023.
- Quimioterapia adyuvante con 4 ciclos de docetaxel y ciclofosfamida, terminada en agosto de 2023.
- Radioterapia en mama izquierda, 15 sesiones, terminada en octubre de 2023.
- Tamoxifeno 20 mg al día desde noviembre de 2023; plan de 5 a 10 años definido por oncología.

- Seguimiento en la Unidad Oncológica del Aburrá cada 6 meses.

Quirúrgicos: Cesáreas en 2008 y 2011. Cuadrantectomía izquierda en 2023.
Farmacológicos actuales: Tamoxifeno 20 mg al día (lo formula oncología).
Alérgicos:
- Medicamentoso: penicilina. Presentó urticaria generalizada en 2010.
- Alimentarios: no refiere.
- Ambientales: no refiere.

Tóxicos y factores de riesgo: No fuma. Alcohol ocasional, una copa de vino al mes. Camina 3 veces por semana.
Gineco-obstétricos: Menarquia a los 12 años. Gestaciones 2, cesáreas 2. Ciclos irregulares desde que inició el tamoxifeno. Fecha de última menstruación: 02/01/2026. Planificación con dispositivo intrauterino de cobre desde 2023, porque no puede usar métodos hormonales.
Familiares:
- Madre: cáncer de mama a los 55 años, viva.
- Tía materna: cáncer de ovario a los 60 años.
- Padre: diabetes tipo 2.

6. REVISIÓN POR SISTEMAS
Generales: bochornos, sudoración nocturna y cansancio, descritos en la enfermedad actual.
Mental: dificultad para dormir. Sin síntomas depresivos.
Demás sistemas: sin hallazgos.

7. SIGNOS VITALES Y MEDIDAS
Tensión arterial: 118/74 mmHg
Frecuencia cardiaca: 76 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria: 15 respiraciones por minuto
Temperatura: 36,4 °C
Saturación de oxígeno: 98 % al aire ambiente
Peso: 64,0 kg
Talla: 1,63 m
Índice de masa corporal: 24,1 kg/m²

8. EXAMEN FÍSICO
Aspecto general: alerta, buen estado general.
Mamas: mama izquierda con cicatriz de cuadrantectomía en cuadrante superior externo, sin nódulos, retracción ni cambios en la piel. Mama derecha sin masas. Axilas y regiones supraclaviculares sin ganglios palpables.
Tórax: ruidos cardiacos rítmicos. Pulmones sin agregados.
Abdomen: blando, sin masas ni crecimiento del hígado.
Extremidades: sin edema. Pantorrillas blandas, no dolorosas.
Columna: sin dolor a la percusión.

9. RESULTADOS DE PARACLÍNICOS
No trae exámenes nuevos. Mamografía bilateral de noviembre de 2025: BI-RADS 2, hallazgos benignos posquirúrgicos.

10. ANÁLISIS
Paciente sin evidencia de enfermedad oncológica, con bochornos frecuentes por el tamoxifeno que le alteran el sueño y el trabajo. Se inicia venlafaxina a dosis baja, que reduce los bochornos sin disminuir el efecto del tamoxifeno. Se evitan fluoxetina y paroxetina, que bloquean la enzima CYP2D6 y hacen que el tamoxifeno funcione menos. Al estar en tamoxifeno debe tener control ginecológico anual, por el riesgo de cambios en el endometrio.

11. DIAGNÓSTICOS (CIE-10)
Principal: Z85.3 Historia personal de tumor maligno de la mama · Confirmado repetido
Relacionado: R23.2 Rubor (bochornos asociados al tamoxifeno) · Confirmado nuevo

Relacionado: G47.0 Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño (insomnio) · Confirmado nuevo

12. PLAN DE MANEJO

12.1 Fórmula médica
1. Venlafaxina 37,5 mg cápsula de liberación prolongada. Una cápsula por vía oral en la mañana. Duración: 90 días. Cantidad: 90 cápsulas.
Continúa tamoxifeno 20 mg al día, formulado por oncología.

12.2 Órdenes de exámenes y procedimientos
- Hemograma completo.
- Perfil hepático: ALT, AST y fosfatasa alcalina.
- Perfil lipídico.

12.3 Remisiones e interconsultas
- Ginecología: control anual por uso de tamoxifeno.

12.4 Incapacidad
No se otorga.

12.5 Recomendaciones y educación
Habitación fresca y ropa de cama ligera. Evitar café después del mediodía, picantes y alcohol. Horario fijo para acostarse y levantarse; no usar el celular en la cama. La venlafaxina puede dar náuseas leves la primera semana; tomarla con el desayuno. No suspender la venlafaxina de golpe. No tomar fluoxetina ni paroxetina mientras use tamoxifeno.

12.6 Signos de alarma
Consultar si presenta sangrado vaginal anormal, dolor en huesos que no cede, masa en una mama o en la axila, dolor o hinchazón en una pantorrilla, falta de aire súbita o tristeza persistente.

12.7 Próximo control
En 3 meses, con los laboratorios.

13. DESTINO AL FINALIZAR LA ATENCIÓN
Domicilio.

14. PROFESIONAL QUE ATIENDE
Santiago Arango Vélez · Médico general
Cédula de ciudadanía 71.385.902 · Registro médico 05-3381-12
Firmado electrónicamente el 20/01/2026 a las 10:30

Documento de prueba con datos inventados. No corresponde a ninguna persona ni institución real.
FIN DE LA HISTORIA